

--

Name: زينب محمود محمد محمود National ID: 27408230101583	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Tamoxifen therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

زینب
محمود محمد محمود
٢ ح سيد صالح شش الاقصر
امبابه - الجيزه

١٩٧٤/٠١/٢٣ ٢٠٧٤ ٠٨ ٢٣ ٠١ ١٥ ٨٣

KQ8856265

٢٠٢٤/٠٧ ٢٧٤٠٨٢٣٠١٠١٥٨٣

حاصلته على دبلوم صناعي
أنثى مسلمة متزوجة
مجدى احمد حافظ شرف
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٧/٢٢

١



جاءه الإصدار بفرع الجيزة

تاريخ الإصدار: 2023-2-14

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) زينب محمود محمد بطاقة رقم 27408230101583

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اي مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا



تاريخ الطباعة: 2023-2-14
يعتمد...



مسلسل 440459

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Name: زينب محمود محمد محمود		
MR. : 3168		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحيّة طيبة وبعد,,		
إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:	رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه Adjuvant tamoxifen therapy was continued for five years, after which a shift in treatment was planned; a workup was requested. The patient is a case of breast cancer currently receiving tamoxifen therapy and supportive treatment. The patient is scheduled for a pause and bilateral breast surgery free of disease on 30/3/2026, with tamoxifen therapy planned for an additional three months.		
تحريراً في ,		
التاريخ :	20-09-2026	الوقت :
الطبيب المعالج :	nada mohamed elsayed	
يعتمد ,		



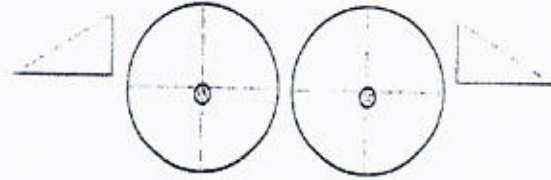
مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستراتيجية
طبعة
مصر

MDT FORM

Post-op

Name	زينة محمد
Age	46 years
MRN	
ID	٢٧٤٠٨٢٢٠١٠١٥٨٢
Co morbidity	١٢٨٢٠٦٤٦٩٢



Clinical Data

Bx: I LC grade II	SM: Rt. Breast mass & axillary LNs
IHC: ER: 5/8 PR: 4/8 Her2: -ve Ki67: 3%	Mets Workup: free
PT3pN2 M0 by CT	
COMMENT: done Rt. MRM	

Ecto
66%

MDT OUTCOME & PLAN

for Bone scan
for A. J. Ch. Acute - structure by X2
+ 0 p(0) RTR.
+ 0 ml at 26 dex + TAmoxif.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

LAIC

Name: Zeinab Mahmoud Mohamed

Date: 12/06/2021

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

**** Known case of breast cancer.**

1. Chest:

- Right breast heterogeneously enhancing parenchyma with lower outer quadrant small enhancing nodule.
- Prominent left axillary lymph nodes.
- Bilateral pulmonary fine subpleural reticular infiltrates.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- Mildly enlarged liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Distension and fecal loading of the rectum.
- No lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

- **No gross pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.**

Dr. Mohammed Qayati, Msc

Dr. Amr Farouk, MD



National Women's Health Initiative
Pathology Lab

معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة



Pathology Report

Name: زينب محمود محمد

Age : 50 years.

Clinical data: Right breast cancer

Specimen type: Right MRM after frozen(+)

Date (Received): 11 /7/2021

Date(reported): 19/8/2021(IPT)

Lab. Number: 1490 / 21

Hospital Number:

Gross Examination:

Two specimens were received and submitted as:

- (1) A fibrofatty tissue piece measure 3.5x2.5 cm containing 4 SLNs up to 1.8x1.5 cm.

Right MRM, 21x16x3 cm, covering skin 15x18 cm, nipple was retracted, axillary fat 6x3 cm. Cut sections revealed 22 nodules up to 1.5 cm. Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5), & Ki67 (30-9) Inform Her2

- Procedure: MRM
- Localization: Right
- Tumor extent
 - Number: One
 - Size: 7.5x6x2.5 cm
 - Skin involvement: N/A
- Distance from margins: N/A
- Lymph nodes number and size: 23LNs, up to 1.5 cm in diameter.
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A

Microscopic examination:

- Invasive lobular carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): **G II**
- Angioinvasion:
- Ductal carcinoma in situ: **Minimal**
- Lymph node involvement: **5/23**
- Resection Margins: **Free**
 - Free /DCIS/ invasive carcinoma
- Additional pathologic findings: **N/A**

Diagnosis:

Right modified radical mastectomy:

- Invasive lobular carcinoma grade II.
- Minimal insitu lobular component.
- Positive perineural infiltration.
- Positive lymphovascular emboli.
- Positive lymph node metastatic deposits (5/23).
- Free nipple, skin and resection margins.
- pT2 pN2 pMx.
- ER: Strong 90% nuclear reaction (Allred score 8/8)
- PR: Strong 90% nuclear reaction (Allred score 8/8)
- Her2: No membrane reaction (score 0)
- Ki67: 5% nuclear reaction

Prof. Dr. Lubna Omar.

Dr. Mona Mohamed.